Hígado, porta e ictericia

SEMIOLOGIA · Clase 27 · bilirrubina, colestasis, hepatomegalia y encefalopatía

1 · QUÉ ES LA ICTERICIA Y DÓNDE SE VE

Ictericia
coloración amarilla de escleróticas, piel y mucosas por bilirrubina elevada en sangre

F1 · **Valores normales**
bilirrubina total hasta 1,2 mg/dL; directa ~0,2-0,3 e indirecta ~0,8 (literatura)

solo se ve muy por encima del

se nota recién desde el

F2 · **Umbral de visibilidad**
se ve solo con más de 2,5 mg/dL; mejor con luz solar

se busca primero en las

F2 · **Dónde buscarla**
escleróticas primero, luego frenillo lingual y conjuntiva; en piel oscura, el paladar

si la esclerótica está blanca, es

Hipercarotinemia
piel amarilla con escleróticas blancas: no es ictericia

nace de la destrucción de

2 · EL VIAJE NORMAL DE LA BILIRRUBINA

Hematíes viejos
a los 120 días se destruyen (80 % en bazo e hígado); su hemoglobina origina la bilirrubina

si se destruyen de más, hay

su hemoglobina da la

Bilirrubina indirecta
liposoluble, unida a albúmina; *no filtra: por eso no hay coluria en* riñón

en el hepatocito se transforma por

Hepatocito
la conjuga con UDP-glucuroniltransferasa + ácido glucurónico

al conjugarla forma la

Bilirrubina directa
hidrosoluble; sale con la bilis por el colédoco al duodeno

baja por el colédoco al

Intestino
las bacterias forman urobilinógeno: 80 % sale como estercobilina y 20 % se reabsorbe

el 80 % sale y colorea las

Heces de color castaño: la bilis llega al intestino

según dónde falla el viaje, hay

3 · TRES NIVELES DE FALLA: ANTES, EN Y DESPUÉS DEL HÍGADO

Tres niveles de falla
antes del hígado, en el hepatocito o después, en la vía biliar

si se produce de más

si falla el hepatocito

daña el hepatocito y causa

si la bilis no sale

Daño del hepatocito
hepatitis viral o alcohólica, cirrosis y fármacos hepatotóxicos

Prehepática (hemólisis)
sube la indirecta; sin coluria, heces muy coloreadas; la total rara vez pasa de 5 mg/dL

Hepatocelular
suben ambas fracciones; orina caoba con coluria y heces hipocólicas

Obstructiva
sube la directa; coluria intensa + acolia y prurito

se confirma con los

4 · OBSTRUCCIÓN: CÁLCULO, TUMOR Y PRURITO

su mecanismo es la

Colestasis
la bilis ya formada no baja y refluye a la sangre con sus sales biliares

la causa más frecuente es la

también la causa un

refluye y deposita las

sin bilis en el intestino se pierde

F4 · **Coledocolitiasis**
causa más frecuente: cálculo migrado de la vesícula; se sospecha si tras un cólico aparece ictericia

F5 · **Tumor de cabeza de páncreas**
(o de vía biliar o vesícula) tapa el colédoco poco a poco

F3 · **Sales biliares en piel**
normalmente ausentes; en la colestasis refluyen y se depositan

Malabsorción de A, D, E y K
sin vitamina K bajan los factores II, VII, IX y X y aparece sangrado

en la piel producen

si se infecta detrás del cálculo, da

distiende la vesícula sin dolor: da

F5 · **Courvoisier-Terrier**
vesícula palpable, distendida, en pera e indolora en un ictérico, casi siempre mayor de 60 años

Colangitis
fiebre con escalofríos en un ictérico: la bilis estancada se infecta

F3 · **Prurito**
intenso, con marcas de rascado: indica colestasis

si no se trata, obliga a

si es grave, obliga a

distingue cáncer de cálculo

Vesícula grande que no duele en un ictérico: sospechar cáncer, no cálculo (el cálculo duele o esclerosa)

orienta la

con coluria y acolia orienta

La obstrucción prolongada deja prurito, sangrado o infección: hay que localizarla y tratar la causa

5 · ORINA, HECES Y LABORATORIO

se confirma con los

Exámenes
bilirrubina total y fraccionada, TGO/TGP, fosfatasa alcalina y ecografía abdominal

sin bilis en el intestino hay

se interpretan con la

Regla de lectura
sin coluria + indirecta alta: pre; coluria + transaminasas altas (necrosis): hepática; coluria + acolia + fosfatasa alcalina alta: post

la directa filtra y da

Coluria
orina oscura como coca-cola: la directa hidrosoluble filtra por el riñón

Acolia
heces como masilla: sin bilis en el intestino no hay estercobilina

sin bilis no hay estercobilina: nto con la coluria orienta a

junto con la acolia orienta a

separa los tres niveles y define el

Queda definido el nivel de la ictericia y con él la conducta sobre la causa

puede agrandar el

6 · EL HÍGADO QUE CRECE Y LA PORTA

F6 · **Hepatomegalia**
IC derecha, colestasis extrahepática, cirrosis, hepatitis viral o alcohólica, esteatosis, neoplasias, linfomas y quiste hidatídico en nuestro medio

solo duele si se distiende la

Cápsula de Glisson
el parénquima no duele; duele la cápsula si se distiende rápido

si crece rápido da el

si crece lento da el

F6 · **Hígado congestivo o inflamatorio**
grande, liso, blando y doloroso

F6 · **Hígado cirrótico**
borde duro y cortante, indoloro: la cápsula se adapta al crecimiento lento

F7 · **Vena porta** ()
nace tras la cabeza del páncreas de la mesentérica superior + esplénica (que recibe a la mesentérica inferior); recibe las gástricas

según dolor y consistencia orienta a

según dolor y consistencia orienta a

al obstruir el flujo causa

si su flujo se obstruye hay

Doloroso y blando: proceso agudo o congestión; duro e indoloro: cirrosis o neoplasia

Hipertensión portal
si el flujo se obstruye (cirrosis, trombosis) sube la presión esplácnica

produce las

Consecuencias
ascitis, esplenomegalia y circulación colateral con várices esofágicas

en conjunto delatan la

Ascitis, bazo y colaterales delatan la hipertensión portal; las várices pueden sangrar

7 · CUANDO EL HÍGADO FALLA: ENCEFALOPATÍA

si es crónica y avanzada, lleva a la

F8 · F9 · **Insuficiencia hepática avanzada**
aguda (hepatitis fulminante) o crónica (cirrosis avanzada)

F9 · **Desencadenantes**
hemorragia digestiva, exceso de proteínas, estreñimiento, alcohol, infecciones, diuréticos y sedantes

se ve en los

no depura el

precipitan el efecto del

Estigmas
arañas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, ictericia, ascitis y fetor

F8 · **Amonio no depurado**
el hígado no lo elimina y llega al cerebro

intoxica el cerebro y da la

Encefalopatía hepática
confusión, cambios de personalidad e inversión del sueño; asterixis y fetor hepático

progresa por

Fases
1: reflejos aumentados; 2: reflejos disminuidos con Babinski positivo; 3: coma

termina en el

Coma hepático: revierte con dieta hipoproteica, laxantes y antibióticos, pero puede repetirse

junto a la hipertensión portal

concepto · diagnóstico · técnica · ejemplo · causa · mecanismo · desenlace · signo · síntoma · complicación · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 09a, 09d y 09e · Sotomayor — teoría del docente (= literatura)